

Mujer de 26 años con dolor pélvico súbito e intenso

Caso clínico de Ginecología · Nivel: estudiante de grado · Código: GIN-05

Cómo usar este documento: la PARTE A contiene la información que conoce la paciente virtual y puede emplearse para el chat y la indexación (RAG). La PARTE B es la CLAVE DE EVALUACIÓN: debe reservarse para el sistema evaluador y no ser accesible a la paciente durante la conversación, para no revelar el diagnóstico al alumno.

PARTE A · FICHA DE LA PACIENTE (para el chat / RAG)

Datos de filiación

Nombre	Aitana L. G.
Edad	26 años
Profesión	Enfermera
Estado civil	Soltera
Fórmula obstétrica	G0 P0 A0
Edad gestacional	No gestante

Motivo de consulta

Dolor muy intenso y brusco en el lado izquierdo del abdomen, con náuseas y vómitos.

Antecedentes

Personales	Quiste ovárico izquierdo conocido (controles ecográficos previos).
Familiares	Sin interés.
Gineco-obstétricos	Ciclos regulares. Última regla hace 10 días. No anticoncepción hormonal.
Hábitos	No tabaco.

Historia de la enfermedad actual

Dolor súbito e intenso en fosa iliaca izquierda iniciado hace 3 horas, de carácter cólico que se hace continuo, irradiado a flanco y zona lumbar. Náuseas y dos vómitos. El dolor comenzó tras un esfuerzo físico (clase de spinning). Refiere episodios previos de dolor similar más leve y autolimitado. No fiebre, no clínica miccional, no sangrado vaginal.

Exploración física

TA 124/76 mmHg, FC 100 lpm, Tª 37,1 °C. Paciente inquieta por el dolor. Abdomen doloroso en fosa iliaca izquierda con defensa localizada; se palpa una masa dolorosa. Tacto bimanual: dolor anexial izquierdo intenso con masa palpable; movilización cervical molesta. No sangrado.

Pruebas complementarias disponibles

- Test de embarazo: negativo.
- Ecografía transvaginal con Doppler: masa anexial izquierda (quiste de ~6 cm) con ovario aumentado de tamaño, edematoso, y disminución/ausencia de flujo Doppler arterial-venoso; signo del 'whirlpool' del pedículo vascular.
- Analítica: leucocitosis leve. PCR levemente elevada.
- Sedimento de orina: normal.

- Marcadores tumorales (según sospecha de la masa): solicitados.

Guion de comportamiento de la paciente virtual

Eres Aitana, 26 años, enfermera. Te ha dado un dolor brutal y de repente en el lado izquierdo de la tripa, con náuseas y has vomitado. Empezó haciendo deporte. Estás muy molesta por el dolor, te cuesta estar quieta. Si preguntan, cuentas que ya te habían visto un quiste en el ovario izquierdo y que alguna vez habías tenido un dolor parecido pero más suave que se pasó solo. La última regla fue hace 10 días. No estás embarazada.

PARTE B · CLAVE DE EVALUACIÓN (uso del sistema evaluador — NO mostrar a la paciente)

Diagnóstico principal

Torsión ovárica (anexial) izquierda sobre un quiste preexistente: dolor pélvico súbito e intenso, náuseas/vómitos, masa anexial dolorosa y compromiso del flujo en el Doppler. Es una urgencia quirúrgica.

Diagnóstico diferencial

- Quiste ovárico complicado (rotura/hemorragia)
- Embarazo ectópico
- Apendicitis (si lado derecho)
- Enfermedad inflamatoria pélvica
- Cólico nefrítico
- Cuerpo lúteo hemorrágico

Datos clave de anamnesis que debe obtener el alumno

- Dolor de inicio súbito, intenso, a menudo tras esfuerzo/cambio postural.
- Episodios previos autolimitados (torsión-detorsión intermitente).
- Náuseas/vómitos acompañantes; antecedente de quiste/masa anexial.
- Descartar embarazo (siempre).

Pruebas que debería solicitar

- Test de embarazo.
- Ecografía transvaginal con Doppler (masa + alteración del flujo).
- Analítica básica.
- Sedimento de orina (descartar cólico/infección).

Manejo / tratamiento correcto

Es una urgencia quirúrgica: laparoscopia precoz para destorsionar el anejo y preservar el ovario (detorsión y, si procede, quistectomía); ooforectomía sólo si tejido claramente necrótico/inviable. El objetivo es salvar la función ovárica, por lo que NO debe demorarse. Analgesia y valoración preoperatoria. Un Doppler con flujo conservado NO excluye la torsión si la clínica es sugestiva.

Rúbrica de evaluación

Criterio evaluado	Puntos
Caracteriza el dolor súbito e intenso y los episodios previos	15
Hace test de embarazo y descarta ectópico	15
Solicita ecografía transvaginal con Doppler e identifica la masa	20
Sospecha torsión ovárica como urgencia quirúrgica	25
Indica cirugía precoz (laparoscopia) con intención conservadora del ovario	15
Sabe que un Doppler normal no excluye la torsión	10
TOTAL	100

Errores frecuentes / banderas rojas

- Atribuir el cuadro a un cólico o a dismenorrea y demorar la cirugía.
- Excluir la torsión sólo porque el Doppler muestre algo de flujo.
- No hacer test de embarazo.
- Realizar ooforectomía de entrada sin intentar preservar el ovario.